SDD 132 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatre

Date : 26/01/2024
Auteur : RAVEL Anaïs (DES Psychiatrie, 2023)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie, 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Communication interprofessionnel
Item(s) en lien avec la station	Item 71 - Trouble du comportement alimentaire
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 132 - Trouble du comportement alimentaire
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de pédopsychiatrie de liaison.
Vous recevez un appel téléphonique de l'interne de pédiatrie concernant une jeune fille hospitalisée sur la garde de la nuit.

Il s'agit de Lucile, 14 ans, en classe de 3ème. Elle a été emmenée cette nuit aux urgences par sa mère à la suite d'une perte de connaissance et a été gardée en hospitalisation.

L'interne de pédiatrie vous contacte devant une jeune fille qui a été retrouvée dans le cellier en train de voler des biscuits. Il voudrait avoir votre avis sur ce comportement.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Interroger votre collègue
- Lui proposer une hypothèse diagnostique.

Vous ne devez pas :

- Interroger sur des signes issue de l'examen clinique
- Rechercher des symptômes de comorbidité anxieuse ou dépressive
- Etablir la suite de la prise en charge de la jeune fille

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec personnel soignant standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
Rubrique 1 : Trouble du comportement alimentaire		
1.	Interroge la quantité de la prise alimentaire lors des repas	1 pt
2.	Interroge l'existence de la prise alimentaire en dehors des repas	1pt
3.	Interroge la quantité de la prise alimentaire en dehors des repas	1pt
4.	Interroge l'aspect compulsif ou obsessionnel de la prise alimentaire en dehors des repas	1 pt
5.	Interroge la fréquence des prises alimentaires en dehors des repas	1 pt
6.	Interroge depuis quand ces prises alimentaires en dehors des repas existent	1 pt
7.	Interroge les ressentis lié à ces prises alimentaires en dehors des repas	1 pt
8.	Interroge la présence de comportement compensatoire (au moins 2 pour avoir le pt) : ● Vomissement purgatif ● Prise de laxatifs ● Pratique excessive de sport ● Périodes de jeûne	1 pt
Rubrique 2 : Recueil d'information annexe		
9.	Interroge l'estime de soi ou l'image du corps	1 pt
10.	Interroge le surinvestissement scolaire ou social	1 pt
11.	Interroge l'environnement familial ou social	1 pt
Rubrique 3 : Hypothèse diagnostique		
12.	Émet l'hypothèse d'un trouble du comportement alimentaire	1 pt
13.	Émet l'hypothèse d'une boulimie / de crises boulimiques	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication) — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

TOTAL (max 20 items)	**16 points**

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

- interne de pédiatrie, appel téléphonique à l'interne de pédopsychiatrie de liaison concernant une patiente admise cette nuit
- rester professionnel, s'adapter au tutoiement/vouvoiement du candidat médecin (discussion d'interne à interne donc tutoiement possible)

Plan de la station ECOS :

Candidat.e et soignant.e simulé.e de part et d'autres du bureau, assis sur des chaises

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

« Je t'appelle/vous appelle pour Lucile, une jeune-fille de 14 ans, hospitalisée chez nous. Je suis préoccupée par son comportement face à la nourriture. Elle a été surprise dans le cellier à plusieurs reprises pour voler des biscuits »

Identité du patient :

Lucile BAILLARD, 14ans, femme
1m32, 29kg, IMC 16 kg/m2

Mode de vie :

en classe de 3ème, collège public
- Première de sa classe, excellents résultats scolaires
- A 2 grands frères de 15 et 17 ans qui vivent à l'internat de leur lycée
- Parents divorcés, vit avec sa maman principalement, voit son papa 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, pas très proche de son papa qui « crie beaucoup »
- Maman cadre sage-femme dans une clinique, papa patron d'une boite d'experts-comptables
- Joue du piano au conservatoire et pratique l'équitation, ne fait pas particulièrement de sport à côté de ça, fait régulièrement des concours de musique et d'équitation
- Déléguée de classe chaque année depuis la 6ème, représente les élèves au conseil d'administration de son collège
- A peu d'ami.e.s, a surtout des copines auprès desquelles elle n'ose pas se confier
- Pas de prise d'alcool, de tabac ou de toxique (perso ou famille)

Comportement global :

Interne : calme, à l'écoute, professionnel

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Pilule contraceptive

Symptômes positifs :

- Si vous demande comment elle mange lors des repas : " Elle mange normalement lors des repas"
- Si demande ce que pense la patiente de son geste : "Elle explique avoir eu besoin de manger à ce moment-là et comme personne ne répondait elle est allée se servir"

Constantes :

Questions de relance :

Si n’a pas donné d’hypothèse diagnostique 30 secondes avant la fin ; “Du coup tu penses que ce comportement est dû à quoi ?”